

Parálisis facial

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

Bibliografía: **Normas H. Elizalde: “Parálisis facial periférica”**

Funciones del nervio facial

El nervio facial es un nervio mixto con función preferentemente motora, y la porción sensitiva recoge impresiones gustativas y la sensibilidad de los dos tercios anteriores de la lengua.

- **Función motora:** Es el nervio motor somático de los músculos cutáneos de la cara y del cuello.
- **Función sensorial:** Recoge el sentido del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua.
- **Función de sensibilidad general:** Recoge la sensibilidad de la piel del dorso de la oreja y para el conducto auditivo externo.
- **Función motora visceral:** forma parte del parasimpático craneal al poseer fibras secretoras y vasodilatadoras, inervar las glándulas lagrimales, las sudoríparas de la cara, las salivales sublingual y submaxilar, la arteria auditiva y sus ramas y los vasos de las mucosas del paladar nasofaríngeo y fosas nasales.

Tipos de afectación

Periféricas

Producen parálisis de los músculos faciales de un lado de la cara, acompañada de alteraciones de la secreción lagrimal (cuando la lesión es proximal al nervio petroso superficial mayor) y salival, y de la sensibilidad gustativa, dependiendo del trayecto lesionado del nervio. Las lesiones próximas al ganglio geniculado provocan además parálisis de las funciones motoras gustativas y secretoras.

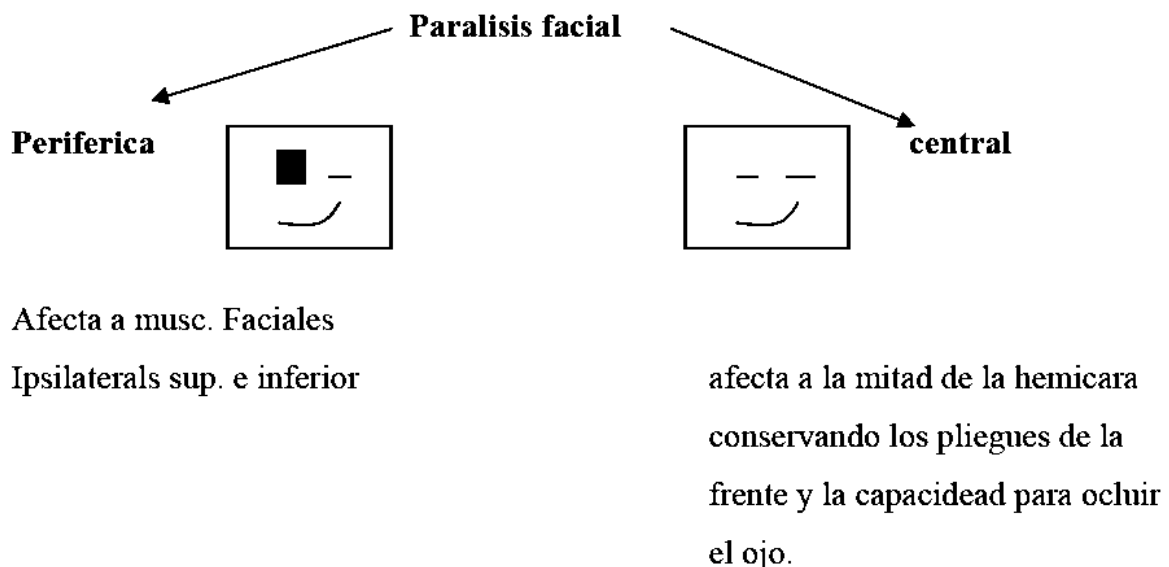
Existiendo hiperacusia, si la lesión es próxima al nervio estapedio.

Si la lesión es proximal a la cuerda del tímpano (fx de peñazco o infección de oído medio), se pierde el gusto de los dos tercios anteriores de la hemilengua.

Las lesiones en el agujero estilomastoideo provocan sólo parálisis de los músculos faciales.

Central (parálisis supranuclear)

Se diferencia de las parálisis periféricas por la presencia de síntomas de afectación de otras estructuras del SNC, la preservación de los músculos frontal y orbicular de los párpados, que poseen una inervación bilateral, y por una discrepancia notable entre la afectación de los movimientos faciales volitivos y emocionales.



Etiología de la parálisis central

Es poco frecuente

ACV, tumores e infecciones

Etiología de las parálisis periféricas

Parálisis facial idiopática (Parálisis de Bell)

Es la más frecuente de parálisis facial

Su etiología es desconocida, existiendo numerosas teorías etiopatogénicas (vascular, vírica, inmunológica), ninguna de ellas está suficientemente demostrada.

Teoría vascular

Una alteración de la microcirculación daría lugar a un edema del nervio en el interior del conducto de Falopio, dificultando el retorno venoso, dañando progresivamente el nervio.

Teoría viral

Explicaría la parálisis por una infección vírica del nervio, por herpes simple. La neuritis produce una edematización del nervio, añadiéndose la respuesta inmunológica provocada como respuesta a la infección vírica.

También se ha defendido factores hereditarios, debido a que en la cuarta parte de los pacientes, existen antecedentes familiares.

Su inicio es agudo, con una máxima afectación, en el 50% de los casos, en las primeras 48 horas; acompañándose, a veces, de dolor retroauricular.

El 80% de los pacientes se recuperan a las 3-4 semanas.

Examen físico

Examen neurológico, otorrinolaringológico completo, fondo de ojo y control de la TA.

El seguimiento es mensual hasta la desaparición de los síntomas.

Tratamiento

1- Medidas físicas

Para proteger el ojo de la sequedad e irritación por cuerpos extraños es necesario utilizar gafas de sol, tapar el ojo y aplicar pomada protectora durante el sueño. Se recomienda el uso de lágrimas artificiales durante el día, masajes y ejercicios.

2- Tratamiento médico

Vitamina B12: no hay trabajos que demuestren su utilidad, podría indicarse por su conocida acción para la síntesis de mielina y por que no produce efectos tóxicos.

Aunque no hay datos concluyentes acerca del beneficio, es recomendado dentro de los 10 días de iniciado el cuadro, el uso de Aciclovir más prednisona (1mg/kg/día) por 7 días.

Parálisis facial traumática secundaria a un TEC

Parálisis facial tumoral

Se produce por tumores intrínsecos (neurinoma del facial, hemangioma, meningioma) o por tumores extrínsecos (neurinoma del acústico, quemodectoma, carcinoma de oído, tumores parotídeos, carcinoma primario o metastásico de hueso temporal, leucemia, rhabdomyosarcoma). Los más frecuentes son los tumores malignos parotídeos.

Herpes zoster ótico: Sdr Ramsay-Hunt

Es una neuritis del VII par, provocada por el virus varicela - zoster, que se manifiesta mediante la triada: otalgia, vesículas en el pabellón auricular y parálisis facial. Pueden afectarse otros pares craneales (V, VIII, IX, X, XI). Se presenta a cualquier edad, aunque es raro durante la infancia. Es frecuente el prodromo viral, con sensación de enfermedad y febrícula o fiebre. La otalgia unilateral e intensa, suele preceder a la

erupción vesiculosa, que se manifiesta en el CAE, concha, pabellón, aunque también puede verse en cuello, cara, mucosa bucal, o lengua.

La parálisis facial aparece en el 20% de los casos de herpes zoster ótico, antes o después de las lesiones cutáneas y suele ser brusca y completa.

Parálisis facial por otitis

A. Otitis Media Aguda.

La aparición de parálisis facial en el curso de una otitis media aguda es poco frecuente.

B. Otitis media crónica.

Habitualmente se produce por invasión del canal de Falopio por un colesteatoma. Es imprescindible tratamiento quirúrgico de urgencia para descompresión quirúrgica del nervio. Si la etiología es TBC o LUES, se administra tratamiento específico.

Parálisis facial yatrogénicas.

En cirugía otológica la frecuencia global de parálisis facial es 0.1-3%, siendo mayor en el caso de reintervenciones y en caso de malformaciones del nervio.